La OMS publica una guía práctica para la desinstitucionalización de los hospitales psiquiátricos, un estudio en Nature Mental Health asocia la conectividad intrahipocampal con la evolución clínica en el riesgo de psicosis y la Academia de Psicología de España convoca un seminario sobre la Ley del Sistema Universitario: claves del 11 de octubre de 2026

DOMINGO 11 DE OCTUBRE DE 2026

Resumen rápido del día

La OMS ha publicado una guía práctica de 146 páginas dirigida a líderes de hospitales psiquiátricos para apoyar la desinstitucionalización de adultos con estancias largas. Un estudio en Nature Mental Health con 434 participantes del proyecto NAPLS-3 asocia el descenso de la conectividad intrahipocampal con el empeoramiento de los síntomas negativos, los síntomas depresivos y el funcionamiento psicosocial en personas con riesgo de psicosis, sin que predijera la transición. Otro trabajo con 23.517 participantes de All of Us describe que una mayor actividad física atenúa la relación entre el riesgo genético y la gravedad de los síntomas depresivos, pero no la del diagnóstico. Un tercer artículo vincula el riesgo poligénico de TDAH con firmas de neuroimagen en 6.001 adolescentes. La

Academia de Psicología de España celebra el 14 de octubre un seminario gratuito sobre la Ley del Sistema Universitario.

Noticias nacionales

NORMATIVA · NACIONAL

La Academia de Psicología de España convoca un seminario gratuito sobre la implantación de la Ley del Sistema Universitario

La Academia de Psicología de España (APE) ha convocado un seminario online gratuito sobre la implantación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, según publica Infocop el 8 de octubre de 2026. La actividad se enmarca en el ciclo de conferencias «Los Miércoles con la Academia», con el que la APE busca generar espacios de reflexión y debate. El seminario se titula «Implantación de la Ley del Sistema Universitario: una apuesta por la movilidad y la internacionalización» y se celebrará el miércoles 14 de octubre de 2026, de 19:00 a 20:30 horas, a través de la plataforma Zoom. Está abierto a profesionales y a público interesado de cualquier lugar. La inscripción es gratuita y se realiza mediante un enlace de registro que Infocop publica en su artículo; la APE dispone además de una página con información sobre la actividad. La moderación corresponde a María Paz García Vera, Académica de Número de la APE, y la intervención a María Vicenta Mestre, también Académica de Número. Según la descripción de Infocop, la sesión se centrará en las implicaciones de la ley para la movilidad y la internacionalización en el ámbito universitario y está planteada como un espacio para conocer la opinión de personas expertas e intercambiar ideas. El artículo no incluye un programa detallado ni una agenda por bloques de contenido; esa información, de existir, habría que consultarla en la página de la APE.

Fuente: Infocop (Consejo General de la Psicología de España), 8 de octubre de 2026

Noticias internacionales

SALUD PÚBLICA · INTERNACIONAL

La OMS publica una guía práctica para apoyar la desinstitucionalización de los hospitales psiquiátricos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado el 9 de octubre de 2026 la guía «Supporting the transition to community-based mental health and social care», con el subtítulo «Practical guide to the deinstitutionalization of psychiatric hospitals». El documento, elaborado por el equipo de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental de la OMS, tiene 146 páginas, el ISBN 978-92-4-012413-4 y una licencia CC BY-NC-SA 3.0 IGO. Está dirigido a líderes de hospitales psiquiátricos y a personas con capacidad de decisión, y su objetivo es apoyar la desinstitucionalización de adultos que han tenido estancias largas en estos centros. La página de la OMS indica que responde al predominio continuado de la atención institucional. La guía describe la desinstitucionalización como un proceso que exige una reforma de todo el sistema: alinear políticas, leyes y financiación, desarrollar servicios comunitarios de salud mental y apoyos de vivienda, y transformar las prácticas y las culturas asistenciales. Se apoya en la orientación normativa previa de la OMS y organiza las acciones en tres fases: planificar, preparar y prestar. También las agrupa en tres áreas de influencia del hospital: reducir los ingresos y la duración de las estancias, transformar la atención dentro del hospital y aumentar las altas con apoyo, la continuidad asistencial y la participación comunitaria. Las acciones se ordenan según responsabilidades de liderazgo, alianzas y mandato, y se plantea la coordinación entre hospitales, autoridades, personas con experiencia vivida, familias, profesionales y servicios comunitarios. La página consultada no recoge cifras ni recomendaciones numeradas.

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS), 9 de octubre de 2026

NEUROCIENCIA · INTERNACIONAL

Un estudio en Nature Mental Health asocia el descenso de la conectividad intrahipocampal con una peor evolución clínica en personas con riesgo de psicosis

Nature Mental Health ha publicado online el 7 de octubre de 2026 un estudio cuyo primer firmante es Lukas Roell, con Steffen Zitzmann y Andrew Zalesky

como autores con contribución igual, que analiza la conectividad dentro del hipocampo en el estado de riesgo de psicosis. La muestra fue de 434 participantes: 356 personas con alto riesgo clínico (CHR) de psicosis y 78 controles sanos. Se trata de un análisis de cohorte observacional con datos del estudio multicéntrico norteamericano NAPLS-3, con datos clínicos y de neuroimagen funcional recogidos durante ocho meses y modelos longitudinales de regresión de variable latente. Los autores informan de que el descenso de la conectividad intrahipocampal a lo largo del tiempo acompañó al empeoramiento de los síntomas negativos, de los síntomas depresivos y del funcionamiento psicosocial en las personas en riesgo. No hallaron esa asociación con los síntomas positivos atenuados ni con la cognición, y la relación fue específica del grupo CHR frente a los controles y no apareció en la conectividad de otras áreas cerebrales. Un descenso temprano de la conectividad precedió al empeoramiento posterior de los síntomas negativos, pero no se encontró el orden inverso, y el descenso no predijo la transición a psicosis. Los autores proponen la conectividad intrahipocampal como posible marcador de neuroimagen transdiagnóstico de las trayectorias afectivo-motivacionales y funcionales tempranas, y sugieren que podría ayudar a estratificar a las personas según su evolución esperada y servir como diana de neuroestimulación; son propuestas, no hallazgos establecidos. La página consultada no incluye tamaños del efecto ni valores estadísticos.

Fuente: Nature Mental Health (Roell et al., 2026)

INVESTIGACIÓN · INTERNACIONAL

Un estudio con datos de All of Us describe que la actividad física atenúa la relación entre el riesgo genético y la gravedad de los síntomas depresivos

Nature Mental Health publicó el 2 de octubre de 2026 un estudio firmado por Qiliang He (Universidad de Texas en San Antonio), Jennifer Zhang (Universidad Vanderbilt), Christopher G. Beevers (Universidad de Texas en Austin) y Denver M. Y. Brown (Universidad Estatal de Kansas). Analiza a 23.517 participantes del programa All of Us, con una edad media de unos 56 años (rango de 18 a 92) y un 67,2 % de mujeres, que contaban con secuenciación del genoma completo y con datos de actividad física de largo plazo obtenidos con dispositivos de monitorización, con un tiempo medio de uso de 582 días. La actividad física se

midió como minutos diarios de actividad moderada a vigorosa y como pasos. El trastorno depresivo mayor se definió con un fenotipo de doble fuente que combina la historia clínica electrónica y el autoinforme de un diagnóstico a lo largo de la vida, y la gravedad de los síntomas se derivó de la historia clínica electrónica. Los modelos de regresión, ajustados por covariables demográficas, pusieron a prueba los efectos principales y las interacciones de las puntuaciones de riesgo poligénico y la actividad física. Un mayor riesgo poligénico se asoció con una mayor probabilidad de diagnóstico y una mayor actividad física con un menor riesgo, sin interacciones significativas entre ambos para el inicio del trastorno. En la gravedad de los síntomas, ambos factores tuvieron efectos principales significativos y aparecieron interacciones negativas consistentes en todas las definiciones: una mayor actividad física atenuó la asociación entre el riesgo genético y la carga sintomática. Los autores concluyen que los factores genéticos y conductuales contribuyen en gran medida de forma independiente al inicio, pero interactúan en la expresión de los síntomas, y plantean la actividad física como posible modificador y diana para intervenciones de precisión. La página consultada es una vista previa y no incluye coeficientes ni intervalos de confianza.

Fuente: Nature Mental Health (He et al., 2026)

NEUROCIENCIA · INTERNACIONAL

Un estudio en Nature Mental Health vincula el riesgo poligénico de TDAH con firmas de neuroimagen que predicen inatención e hiperactividad

Nature Mental Health publicó online el 9 de octubre de 2026 un artículo firmado por Xueke Shan, Ming Xu, Dongmei Zhi y otros autores, con Jing Sui como última persona de la lista consultada, que relaciona el riesgo genético de TDAH con patrones cerebrales detectados mediante resonancia magnética. La cohorte de descubrimiento fue el estudio ABCD, con 6.001 participantes (3.333 en el submuestreo de la figura 2), y la validación independiente se hizo con la cohorte ADHD-200, cuyo tamaño no se indica en la página. Los autores usaron un marco supervisado de fusión multimodal de resonancia magnética que vincula la puntuación de riesgo poligénico de TDAH, calculada con datos de resumen de un estudio de asociación del genoma completo del Consorcio de Genómica Psiquiátrica, con la actividad funcional cerebral y el volumen de

materia gris, y con las conductas de inatención e hiperactividad. Según el resumen, las firmas asociadas al riesgo poligénico se concentran en nodos de las redes de control cognitivo y en núcleos del mesencéfalo, que los autores describen como relevantes para la señalización dopaminérgica, con alteraciones tanto en la actividad funcional como en el volumen de materia gris. Las firmas se reprodujeron en submuestras definidas por ancestría y estratificadas por sexo, mostraron una alta especificidad para el TDAH frente a once trastornos psiquiátricos y predijeron la inatención y la hiperactividad tanto en la cohorte de descubrimiento como en ADHD-200. Los autores concluyen que el trabajo aporta una vía hacia firmas cerebrales específicas del TDAH ancladas en lo genético, con potencial transdiagnóstico. La página consultada es una vista previa: no recoge tamaños del efecto, precisión de las predicciones ni valores estadísticos.

Fuente: Nature Mental Health (Shan et al., 2026)

Herramientas clínicas e instrumentos

– **Guía práctica de la OMS sobre desinstitucionalización de hospitales psiquiátricos:** Documento de 146 páginas con licencia CC BY-NC-SA 3.0 IGO que organiza las acciones en las fases de planificar, preparar y prestar. Puede resultar útil como material de consulta para quienes trabajan en la coordinación entre hospitales, servicios comunitarios, familias y personas con experiencia vivida.

– **Seminario gratuito de la Academia de Psicología de España sobre la Ley del Sistema Universitario:** Actividad online del 14 de octubre de 2026, de 19:00 a 20:30 horas, con inscripción gratuita mediante el enlace publicado por Infocop. Puede ser una vía para conocer la opinión de personas expertas sobre movilidad e internacionalización en el ámbito universitario.

Prioridades del día

Prestar atención a los síntomas negativos y afectivos en personas con riesgo de psicosis

Puede ser útil incluir en la evaluación los síntomas negativos, depresivos y el funcionamiento psicosocial en personas con riesgo de psicosis, dado que el estudio de Nature Mental Health los asocia al descenso de la conectividad intrahipocampal. Puede ser relevante recordar que es un hallazgo de investigación en neuroimagen, que el descenso no predijo la transición a psicosis y que no se plantea como herramienta diagnóstica.

Preguntar por la actividad física al explorar los síntomas depresivos

Puede ser oportuno incorporar preguntas sobre la actividad física habitual en la evaluación de la depresión, a la luz de un análisis de asociaciones en el que una mayor actividad atenuó la relación entre el riesgo genético y la gravedad sintomática. Puede ser relevante tener presente que no se halló interacción para el inicio del trastorno y que los resultados no permiten por sí solos establecer causalidad.

Revisar la guía de la OMS si se trabaja con estancias largas o con coordinación comunitaria

Puede ser relevante consultar la guía de la OMS para quienes trabajan con personas con estancias largas en recursos psiquiátricos o en la coordinación con servicios comunitarios, familias y personas con experiencia vivida. Puede ser útil fijarse en su organización por fases y áreas de influencia como marco de referencia, teniendo en cuenta que la página consultada no ofrece cifras ni recomendaciones numeradas.

© 2026 IPP | Instituto Politécnico de Psicología · Observatorio de Actualidad — domingo 11 de octubre de 2026